

25 - La Dépression de l'Enfant et de l'Adolescent - Pr. AABASSI

Bonjour, notre cours d'aujourd'hui s'intitule La dépression de l'enfant et de l'adolescent. Au terme de ce cours, vous serez capables de définir la dépression, de connaître les facteurs de risque de la dépression, de poser le diagnostic de dépression chez l'enfant et ou l'adolescent et de traiter un enfant ou un adolescent déprimé. Nous allons suivre le plan suivant.

La dépression se définit comme étant un trouble de l'humeur caractérisé par un sentiment permanent et envahissant de tristesse, d'irritabilité et de perte de plaisir aux activités quotidiennes. J'entends par permanent la présence tout le temps pendant minimum deux semaines. Envahissant que ces difficultés, il envahisse tous les secteurs de vie, aussi bien qu'à l'école, qu'en famille, qu'avec les amis.

Il s'agit d'un trouble fréquent mais sous-estimé chez la population pédiatrique. Sous-estimé et donc sous-diagnostiqué et maltraité. Il est difficile aux cliniciens de penser qu'un enfant, symbole de joie et d'insouciance, puisse être déprimé.

Ce trouble touche tous les âges, du nourrisson jusqu'au grand adolescent avec une expression clinique qui est très polymorphe. La gravité est l'engagement de pronostics vitaux par le risque de passage à l'acte suicidaire avec la présence de retentissement scolaire, relationnel et familial. La psychothérapie reste le traitement de base.

La médication est indiquée en deuxième intention. Pour l'épidémiologie, c'est un trouble fréquent qui touche 2% des enfants et 5% des adolescents. Ça touche tous les âges, le nourrisson, l'enfant et l'adolescent avec récemment un âge de début de plus en plus précoce.

Pour l'enfant, la fille est touchée comme le garçon. Pour l'adolescent, il y a une prédominance féminine avec un sexe ratio de 2 filles pour 1 garçon. L'écomorbidité est très fréquente présente dans 75% et il faut chercher surtout des troubles anxieux.

La dépression reste un facteur de risque majeur de suicide. Quels sont les facteurs de risque de la dépression? Il y a les facteurs héréditaires. La présence de dépression ou d'antécédents de dépression chez les parents multiplie le risque chez l'enfant x10.

La dépression maternelle dans la période périnatale expose le nourrisson à la dépression. Il y a des facteurs psychosociaux comme des traumatismes aigus, de deuil, de séparation ou plutôt chronique secondaire à une maltraitance, des conflits intrafamiliaux, de harcèlement à l'école ou de la précarité. Le sexe féminin et la puberté semblent prédisposer à la dépression.

Aussi la présence de maladies chroniques, de maladies à pronostic incertain comme les tumeurs cérébrales, l'insuffisance rénale chronique et l'hypothyroïdie. Les troubles anxieux s'accompagnent dans 50% de dépression. Si vous avez des patients qui ont des troubles anxieux, il faut chercher automatiquement la dépression.

Aussi la prise ou sevrage de toxiques ou prise de certains médicaments comme les corticoïdes et les antihypertenseurs sont des facteurs de risque de développement de dépression. Par exemple, si vous avez une patiente pubère qui est suivie pour insuffisance rénale chronique et qui récemment change de comportement ou a un fléchissement des résultats scolaires ou qui devient triste et s'isole, ça doit vous faire penser à une éventuelle dépression. Nous arrivons à l'étude clinique.

Sachez que chez l'enfant, l'expression clinique est variable en fonction de l'âge, de la maturation affective et cognitive et de l'histoire développementale et que la tristesse est souvent marquée par d'autres symptômes d'ordre physique et comportemental. Le type de description est l'état dépressif majeur qui est défini par la présence permanente sur au moins deux semaines d'eux, humeur irritable c'est-à-dire que le moral est bas et il y a un sentiment de tristesse avec l'impression que les autres ne s'occupent pas de l'enfant que cet enfant recherche le conflit avec les autres tout le temps, il est agressif, il est coléreux et il est nerveux, avec une intolérance à la frustration et la contrariété avec des crises de pleurs qui sont très fréquents, absence de réactivité de l'humeur c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amélioration de l'humeur en réponse à des événements de vie positive, par exemple des fêtes ou des anniversaires, avec une perte de plaisir à l'école ou aux jeux et aux activités. Les signes associés sont très fréquents, soit de l'ordre de troubles de comportement, c'est des fugues, des crises de colère ou de l'agressivité ou des troubles de sommeil, l'enfant va se réveiller précocement ou a des réveils qui sont fréquents ou a de l'insomnie, des troubles d'apprentissage, comme des difficultés de mémorisation, des trous de mémoire, des difficultés d'attention et de concentration, avec une perte de l'appétit, un évitement relationnel, il ne joue pas avec les enfants et évite les relations et les conversations avec les adultes et des signes somatiques, de céphalée, de douleur abdominale, de vertige et de fatigue qui sont très fréquents chez l'enfant et qui peuvent parfois être les révélateurs du tableau clinique de la dépression.

Les autres formes cliniques selon l'âge, chez le tout petit enfant, ce sont les difficultés comportementales qui vont marquer le tableau clinique, c'est un enfant nerveux qui se met rapidement en colère avec des crises de pleurs et des crises de colère très fréquentes il est agressif envers les autres enfants et il joue de façon violente. L'enfant d'âge scolaire, le tableau clinique est marqué surtout par les difficultés scolaires, par les trous de mémoire, les difficultés de mémorisation, le sentiment d'ennui et donc il ne peut pas se concentrer à l'école et donc ses résultats scolaires vont fléchir. Les plaintes somatiques marquent aussi le tableau clinique, l'adolescence est plutôt l'irritabilité, l'hypersomnie qui remplace l'insomnie, le sentiment de rejet et les difficultés relationnelles et il faut toujours chercher la présence d'idées de mort et de conduites suicidaires qui sont très fréquentes à cet âge.

Une forme toute particulière de la dépression est la dépression précoce du nourissant. Elle a été décrite par Spitz il y a plusieurs années et elle est associée à des carences affectives chez le bébé. Spitz l'avait décrite chez les enfants des orphelinats.

Note sur la première image la position pathognomonique, c'est un bébé qui va se mettre sur le ventre, qui est en retrait et a un regard flou qui refuse la tétée et qui n'entre pas en interaction avec l'adulte qui va prendre soin de lui. L'enfant ou le nourissant est en retrait complet, en repli, en indifférence relationnelle et parfois même en retard de développement et dans certains cas il y a un arrêt carrément du développement. Les tableaux cliniques selon la sévérité on va définir la dépression légère, moyenne et sévère et cela selon la gravité des signes cliniques, le retentissement global de ces signes cliniques sur l'enfant et la présence ou pas de signes de gravité qu'il faudra retenir qui sont de l'ordre des hallucinations, du suicide et de délire.

Quelques soutiens pertinents qu'il faudra vous noter ici y a la dépression unipolaire c'est à dire la présence de dépression sans antécédent d'épisode maniaque, d'excitation de l'humeur, mixte ou hypomaniaque. La dépression bipolaire c'est à dire une dépression avec antécédent d'au moins un épisode maniaque, mixte ou hypomaniaque. La dépression dysthymique se définit par une humeur dépressive chronique depuis au moins un an mais pas suffisamment sévère, les intervalles asymptomatiques durent moins de deux mois.

La dépression psychotique se définit par la présence en plus de la tristesse, des hallucinations ou de délire. La dépression mélancolique c'est une dépression intense avec un sentiment intense de douleur morale, un ralentissement très manifeste, une inhibition des fonctions psychomotrices et psychiques. Comment porter le diagnostic positif ? Sachez que le diagnostic positif de dépression est un diagnostic purement clinique.

A l'anamnèse, il y a la présence de deux signes majeurs l'humeur irritable et la perte de plaisir que nous avons détaillé tout à l'heure qui sont présents constamment sur au moins deux semaines et noté la rupture avec le fonctionnement antérieur et ou la présence de retentissement sur l'enfant. L'anamnèse définit l'ensemble des antécédents que présente l'enfant et sa famille. C'est ce que nous avons appelé tout à l'heure les facteurs de risque.

Cherchera aussi les signes de gravité, de l'ordre des hallucinations, du délire qui sont normalement congruents à l'humeur, c'est à dire qui sont à thématique de tristesse, à thématique de mort par exemple et recherchera les idées suicidaires et les scénarios suicidaires. On cherchera aussi les comorbidités comme on avait dit tout à l'heure qui sont très fréquentes, l'anxiété, le TDAH, l'abus de substances, l'échec scolaire et les troubles de comportement. Votre observation va relever un enfant ou un adolescent avec des signes de syndrome dépressif, un visage figé, triste, un ralentissement moteur et psychique, un enfant ou un adolescent qui parle peu ou plutôt il est agité et excité.

L'examen clinique est global et minutieux comme toute situation clinique d'évaluation d'enfant. Nous disposons de certaines échelles diagnostiques qui permettent de porter le diagnostic positif de dépression en population pédiatrique, l'échelle CDI, l'échelle CDRS, l'échelle de Beck et l'échelle Kelly-Sachs. Sur l'image, vous voyez un exemple de questionnaire abrégé de Beck.

C'est un auto-questionnaire que l'enfant qui peut lire et écrire et l'adolescent peut remplir tout seul et vous allez récupérer un score qui va définir est-ce qu'il a une dépression ou pas. Quels sont les diagnostics différentiels de dépression? L'adolescence, par le caractère d'irritabilité très fréquente et les sauts fréquents de l'humeur, peut porter à faux avec le tableau de dépression. Les événements de vie douloureux qui peuvent causer de la tristesse peuvent aussi mimer un tableau de dépression.

C'est le deuil et les séparations. Mais ils ne sont pas sagés, ne sont pas permanents. La cause organique comme la dysthyroïdie, l'anémie et la carence vont faire par le ralentissement psychique et physique qu'ils peuvent donner, peuvent porter le diagnostic différentiel avec la dépression.

Des causes psychiatriques comme la schizophrénie débutante et les troubles adaptatifs, les prises médicamenteuses de corticoïdes et des antihypertenseurs, la prise ou le sevrage est toxique sont aussi des diagnostics à éliminer avant de retenir le diagnostic de dépression. Ainsi, l'anamnèse va rechercher les antécédents médicaux, médicamenteux et toxiques, l'examen somatique complet et minutieux, l'examen général et thyroïdien, on peut céder, deux bilans paracliniques selon l'orientation, une numération formule sanguine, une ferritinémie ou un bilan thyroïdien. Comment traiter la dépression? Le traitement doit être mis en place de façon précoce, c'est un traitement individualisé, singulier, adapté à l'enfant qui implique l'entourage, c'est à dire la famille et l'école.

Ses buts, c'est d'obtenir une rémission complète et d'éviter les rechutes puisque la dépression est parmi les troubles psychiatriques qui sont marquées par les rechutes très fréquentes. Le deuxième but étant d'améliorer le fonctionnement en société, à l'école et en relationnel avec les autres. Le cadre, vous allez recevoir ces enfants surtout en ambulatoire, c'est à dire dans vos consultations de médecine générale, de médecine pédiatrique ou dans d'autres spécialités.

L'hospitalisation est indiquée dans les formes sévères, lorsqu'il y a une présence des délires, d'hallucinations, de symptômes sévères, lorsqu'il y a un risque suicidaire ou un risque de passage à l'acte violent vers autrui ou vers soi-même. L'hospitalisation se fait au service de pédiatrie ou au service de pédopsychiatrie. La psychothérapie est la clé du traitement.

Vous serez amené à faire de la psychothérapie de soutien qui est basée sur la reconnaissance de la souffrance de l'enfant. Vous allez déjà reconnaître que l'enfant est en souffrance et cela soulage et aide à l'expression. Vous allez aider l'enfant à exprimer cette souffrance par la parole.

Vous allez l'accompagner et le soutenir et éduquer son entourage, c'est-à-dire énoncer que les difficultés relationnelles à l'école sont dues à un trouble mental qui est traitable. Et vous allez agir sur les facteurs stressants. Les psychothérapies plutôt structurées se font par des spécialistes, soit de la psychothérapie d'inspiration analytique au comportemental et cognitif.

La médication est toujours en deuxième intention chez l'enfant. C'est un traitement symptomatique, soit par la mélatonine lorsqu'il y a des troubles du sommeil, par les antihéistaminiques aussi ou par les neuroleptiques sédatifs lorsqu'il y a beaucoup d'irritabilité ou d'agitation ou de troubles de comportement. Les antidépresseurs trouvent leur place au-delà de 8 ans.

La molécule qui a là et même chez l'enfant pour la dépression et la fluoxétine a la dose de 20 mg par jour et est efficace et très bien tolérée. D'autres molécules peuvent être utilisées comme la sertraline et l'écétaloprame. La médication est utilisée en deuxième intention en cas d'inefficacité de la psychothérapie ou lorsque l'efficacité n'est pas assez suffisante ou dans les formes sévères.

L'attente vigilante c'est le fait d'observer l'évolution pendant un certain temps généralement 14 jours avant de proposer un traitement. On ne fait aucune intervention on va observer l'enfant de façon régulière et rapprochée sans donner de traitement précis. Autre moyen thérapeutique est la guidance parentale ou les interventions scolaires.

Vous allez prendre contact avec l'école pour faire des aménagements scolaires pour un arrêt de scolarité lorsque l'enfant ne peut pas se concentrer ou pour par exemple aménager les évaluations. Les indications. Pour les formes légères on opte pour l'attente vigilante pendant 14 jours avec un suivi et une réévaluation chaque semaine.

On peut instaurer aussi au même temps une psychothérapie de soutien et le suivi et les rapprocher. Pour les formes moyennes on va indiquer une psychothérapie structurée chez un spécialiste qui peut faire une psychothérapie comportementale et cognitive ou psychanalytique selon ses dispositions. Les formes sévères l'indication d'ores et déjà des antidépresseurs avec de la psychothérapie.

Qu'en est-il de l'évolution et du pronostic? Sous traitement la dépression évolue bien. On obtient une réémission c'est à dire une disparition des signes cliniques au bout de 3 à 4 semaines. Les rechutes sont très fréquentes et la dépression peut se compliquer de difficultés relationnelles, de difficultés scolaires et d'abus de drogue.

Surtout chez les adolescents qui vont tomber dans la surconsommation de drogue pour un effet autothérapeutique ou ce qu'on appelle de l'automédication par les drogues pour se sédater, pour diminuer le sentiment de souffrance et d'anxiété. Le suicide est un risque majeur dans la dépression. Il faut toujours être vigilant et le chercher activement et la dépression peut continuer à l'âge adulte.

En conclusion, nous avons vu que la dépression est très fréquente en population pédiatrique. Bon nombre d'enfants et d'adolescents, en même titre que les adultes, souffrent de dépression. La recherche active de ce trouble permettra un repérage et une prise en charge précoce.

Ce qui permet de préserver le devenir développemental, scolaire, relationnel et psycho-affectif de l'enfant ou de l'adolescent.